Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Kommission für Fragen zu sexuell übertragbaren Infektionen (EKSI)

Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIST)

Commissione federale per le questioni relative alle infezioni sessualmente trasmissibili (CFIST)

Expositions au VIH en dehors du milieu médical :

Mise à jour 2025 des recommandations pour la prophylaxie post-exposition (PEP) contre le VIH

Auteurs et auteures

Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIST)
7 novembre 2025

Elaborées par Hadrien Komaromi, Zurich, Barbara Jakopp, Aarau, Jan Fehr, Zurich, et en collaboration avec les groupes de travail « clinique et thérapie » et « laboratoire et diagnostic » de la CFIST et avec l'Aide suisse contre le sida.

Les présentes recommandations décrivent le traitement des personnes ayant potentiellement été EXPOSÉES au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dans un contexte non professionnel. Elles ont été élaborées à partir des recommandations de la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS, aujourd'hui Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles, CFIST) publiées en 2014 (1).

► Le principe central reste le même : après une situation à risque, il faut réagir le plus rapidement possible.

Résumé

La prophylaxie post-exposition (PEP) contre le VIH n'est désormais plus recommandée systématiquement à la PERSONNE EXPOSÉE en cas de réception dans la bouche de sperme de la PERSONNE SOURCE porteuse du VIH. La composition médicamenteuse de la PEP VIH a également fait l'objet d'une modification : la prophylaxie de première ligne comprend désormais le ténofovir/emtricitabine en combinaison avec le dolutégravir. Un nouveau paragraphe décrit également la marche à suivre lorsque la personne EXPOSÉE est sous prophylaxie pré-exposition contre le VIH (PrEP VIH), mais n'a pas pris ce traitement régulièrement.

Épidémiologie

Les nouvelles infections par le VIH sont désormais rares en Suisse. Le nombre de nouveaux cas déclarés s'élevait à 352 en 2023, ce qui représente une incidence de 4 cas pour 100 000 habitants (2). Cette situation est liée, d'une part, au fait qu'une proportion importante de personnes porteuses du VIH connaissent leur statut sérologique et bénéficient d'un traitement antirétroviral (TAR) grâce auquel la charge virale dans leur sang se situe sous le seuil de détection (< 50 copies/ml), empêchant ainsi leurs liquides biologiques de devenir contagieux. D'autre part, de plus en plus de personnes ont recours à la PrEP VIH sous l'effet de campagnes de prévention et de dépistage efficaces menées auprès des groupes particulièrement concernés. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) estime qu'en 2023, 2180 personnes vivant en Suisse présentaient une infection par le VIH n'ayant pas encore été diagnostiquée ou ne recevaient pas un traitement optimal et auraient donc pu transmettre le VIH (2).

Efficacité de la PEP VIH

Il n'existe pas de données issues d'essais contrôlés et randomisés sur l'utilisation de la PEP VIH. Les données probantes concernant l'utilisation de la PEP ont été extrapolées à partir de données sur des animaux (3–7) et de petites études observationnelles (8–11). La PEP VIH actuellement recommandée comprend trois substances antirétrovirales, visant ainsi une plus grande efficacité, analogue à celle d'un traitement contre le VIH. Toute consultation en vue d'une PEP VIH doit faire l'objet d'une évaluation individuelle des bénéfices et des risques potentiels du traitement.

PEP VIH : le plus tôt est le mieux !

La PEP VIH est la plus efficace lorsqu'elle est administrée *le plus tôt possible* après l'exposition : *« Chaque heure compte ! »*. Des essais sur des animaux ont montré que le réservoir latent du VIH se constitue très rapidement après un contact avec le virus (7). L'objectif est d'administrer la première dose dans les **quatre heures** qui suivent l'exposition. À partir de 24 heures après l'exposition, le bénéfice est réduit et au-delà de 48 heures, la PEP VIH devient superflue.

Prise en charge en cas d'EXPOSITION potentiellement pertinente au VIH

Si une personne se présente en raison d'une potentielle exposition au VIH dans un contexte non professionnel, il faut lui recommander de toute urgence de faire venir si possible la PERSONNE SOURCE pour un dépistage (test rapide de quatrième génération pour le VIH), car dans la plupart des cas, il sera ainsi possible d'éviter une PEP VIH. Pour le VIH, le test rapide de quatrième génération réalisé par un laboratoire accrédité est équivalent au test de dépistage standard de quatrième génération.

Un test rapide de quatrième génération pour le VIH utilisé en dehors d'un laboratoire ne doit alors être considéré comme fiable que s'il a été réalisé par un personnel qualifié et expérimenté. Si aucun test rapide conforme aux normes de qualité ci-dessus n'est disponible, il est également possible de procéder à un test de laboratoire dans un laboratoire accrédité. Dans ce cas toutefois, le résultat est rarement disponible dans les quatre heures suivant l'EXPOSITION : il faut donc administrer une première dose

de PEP VIH le temps que le résultat soit connu, c'est-à-dire dans les 24 heures. Les tests VIH de troisième génération (c'est-à-dire sans détection des antigènes du VIH p24) ne doivent plus être employés.

Si le test de la PERSONNE SOURCE n'est pas possible dans l'immédiat, la mise en place de la PEP ne doit pas être retardée. Dans leurs services d'urgence hospitaliers ou dans le cadre d'autres soins ambulatoires, les institutions de santé doivent disposer de starter kits (boîtes de comprimés de PEP VIH pour trois à cinq jours) afin de pouvoir les remettre rapidement, ce qui évite à la personne exposée de devoir encore se rendre dans une pharmacie et de perdre ainsi un temps précieux. La dose initiale doit permettre d'écarter le risque d'infection en attendant que le statut sérologique de la PERSONNE SOURCE soit clarifié et qu'il soit possible de prendre une décision concernant la poursuite ou non de la PEP VIH.

Si le résultat du test de dépistage du VIH de la PERSONNE SOURCE est réactif ou si l'ARN du VIH est détecté alors que sa séropositivité est avérée, et si l'EXPOSITION remonte à moins de 48 heures, une PEP VIH est administrée durant un mois : un emballage mensuel (30 comprimés) est prescrit selon les modalités habituelles. Si le résultat du test est négatif et si la PERSONNE SOURCE n'a pas été exposée au risque de contracter le VIH au cours des six semaines précédentes (période de latence sérologique) et qu'elle ne présente pas non plus de symptômes d'une primo-infection par le VIH, on renonce à la PEP VIH ou on l'interrompt. En cas de suspicion de primo-infection par le VIH, il est impératif de procéder à une recherche par PCR de l'ARN du VIH (HIV-qRNA) chez la PERSONNE SOURCE et d'administrer une PEP VIH à la personne exposée jusqu'à ce que les résultats soient disponibles.

Si la PERSONNE SOURCE présente une infection connue au VIH et n'est pas sous traitement antirétroviral (TAR), la PERSONNE EXPOSÉE se voit proposer une PEP VIH. Si la PERSONNE SOURCE porteuse du VIH est sous TAR, il convient de procéder à une recherche de l'ARN du VIH à moins qu'un tel examen ait déjà été réalisé au cours des deux derniers jours, et que le virus n'ait pas été détecté (charge virale < 50 copies/ml). Il est possible, à titre exceptionnel, de renoncer à une nouvelle recherche de l'ARN du VIH dans les sept jours qui suivent le dernier examen (si la charge virale était inférieure à 50 copies/ml) si la PERSONNE SOURCE suit son TAR sans changements et de manière fiable et que sa charge virale est indétectable depuis longtemps. Cette latence permet d'être suffisamment certain que la charge virale n'était pas non plus détectable au moment de l'EXPOSITION et d'éviter ainsi les frais superflus.

Si, dans la situation décrite ci-dessus, le résultat du test de charge virale n'est pas disponible dans les quatre heures, il convient de démarrer une PEP VIH. Si la charge virale du VIH n'est pas détectée chez une personne sous TAR (< 50 copies/ml), on peut mettre un terme à la PEP VIH amorcée ; sinon, la PEP VIH est poursuivie durant un mois entier. Le risque de contamination par une PERSONNE SOURCE sous TAR dont la charge virale n'est pas détectable (c'est-à-dire < 50 copies/ml) au moment de l'EXPOSITION est quasiment nul (12, 13).

En cas de détection de l'ARN du VIH dans le sang (≥ 50 copies/ml) d'une personne sous TAR, il faut s'adresser à un spécialiste du VIH, car il existe potentiellement des résistances, et il est alors impératif de mettre en place une PEP VIH sur mesure pour la PERSONNE EXPOSÉE. S'il n'est pas possible de déterminer un traitement adapté dans les quatre heures suivant l'EXPOSITION, on prescrit alors la première dose d'un traitement standard.

Indication de la PEP VIH

La décision de recourir à une PEP s'appuie, d'une part, sur le risque engendré par l'EXPOSITION elle-même et, d'autre part, sur le risque d'infection par le VIH non traitée chez la PERSONNE SOURCE.

Tableau 1 : Le tableau suivant présente le risque de transmission du VIH suivant le type d'EXPOSITION à une PERSONNE SOURCE séropositive ne faisant pas l'objet d'un traitement efficace contre le VIH.

Type d'EXPOSITION	**Estimation du risque de transmission du VIH par EXPOSITION à une PERSONNE SOURCE dont la charge virale n'a pas été supprimée**
Rapport anal réceptif	1 sur 90
Rapport anal réceptif avec éjaculation	1 sur 65
Rapport anal réceptif sans éjaculation	1 sur 170
Rapport anal insertif	1 sur 666
Rapport anal insertif sans circoncision	1 sur 161
Rapport anal insertif avec circoncision	1 sur 909
Rapport vaginal réceptif	1 sur 1000
Rapport vaginal insertif	1 sur 1219
Éjaculation dans les yeux	<1 sur 10 000
Rapport bucco-génital réceptif (faire une fellation)	<1 sur 10 000
Rapport bucco-génital insertif (recevoir une fellation)	<1 sur 10 000
Transfusion sanguine (un concentré)	1 sur 1
Blessure à l'aiguille (avec saignement)	1 sur 333
Échange de matériel d'injection (y c. chemsex)	1 sur 149
Morsure humaine	<1 sur 10 000

Tableau 1 — adapté de la référence (14)

Prévalence élevée du VIH

Les groupes suivants se caractérisent par une prévalence élevée du VIH et sont donc considérés comme des groupes à risque élevé :

1. Hommes et personnes trans ayant des relations sexuelles avec des hommes
2. Personnes faisant partie de réseaux sexuels comprenant des personnes mentionnées au point 1
3. Personnes qui consomment des substances injectables

4. Personnes issues de pays dans lesquels la prévalence du VIH au sein de la population dans son ensemble est supérieure ou égale à 1 % (la liste à jour se trouve sur la page https://aidsinfo.unaids.org/).

Plusieurs facteurs peuvent accroître davantage le risque de transmission du VIH :

1. Charge virale plasmatique élevée chez la PERSONNE SOURCE : pour chaque augmentation de log10 de l'ARN du VIH, le risque de transmission par exposition augmente de 2,9 fois (15). La charge virale peut être très élevée, en particulier pendant une primo-infection (16).
2. Blessures au niveau de la barrière muqueuse telles que des ulcères de la bouche ou des organes génitaux ou traumatismes anaux ou vaginaux après une agression sexuelle ou un premier rapport sexuel (17–19).
3. Menstruations ou autres saignements (avis d'experts).
4. Grossesse ou période post-partum : le risque d'infection par le VIH par exposition est plus élevé à la fin de la grossesse (risque relatif ajusté [RR ajusté] de 2,82) et au cours de la période qui suit l'accouchement (RR ajusté de 3,97) par rapport au risque d'exposition en dehors de la grossesse (20).
5. Autres infections sexuellement transmissibles concomitantes chez la PERSONNE SOURCE atteinte du VIH et ne bénéficiant pas d'un TAR (21, 22) ainsi que chez la PERSONNE EXPOSÉE.
6. EXPOSITION répétée et/ou rapports avec plusieurs partenaires.

Décision individuelle concernant la PEP VIH

La décision de recourir à une PEP VIH doit être prise individuellement compte tenu du risque estimé de transmission du VIH. Les recommandations de 2014 ont été mises à jour sur la base des expériences et des connaissances de ces dernières années afin de permettre une prise de décision fondée sur la situation épidémiologique actuelle :

PEP recommandée :	le risque d'infection par le VIH est significatif, et la PEP est indiquée.
PEP à évaluer :	le risque d'infection par le VIH est faible, mais une PEP peut être démarrée si des facteurs supplémentaires contribuent à accroître le risque (cf. liste plus haut).
PEP non recommandée systématiquement :	le risque d'infection par le VIH est très faible, et une PEP n'est indiquée ni sur le plan médical ni sur le plan économique. Certaines circonstances peuvent toutefois, au cas par cas, justifier une PEP VIH.

Tableau 2 : le tableau ci-après résume les situations dans lesquelles la PEP est recommandée, peut être envisagée ou n'est pas recommandée systématiquement. Un rapport sexuel avec pénétration avec un préservatif qui a éclaté, s'est déchiré ou a glissé est considéré comme un « rapport sexuel non protégé ».

	PERSONNE SOURCE séropositive avec charge virale > 50 copies/ml ou PERSONNE SOURCE au statut sérologique inconnu et issue d'un groupe à risque élevé	**Statut VIH inconnu d'une PERSONNE SOURCE n'appartenant pas à un groupe à risque élevé de VIH**
Rapport anal réceptif	Recommandée	À évaluer*
Rapport anal insertif	Recommandée	À évaluer
Rapport vaginal réceptif	Recommandée	À évaluer*
Rapport vaginal insertif	Recommandée	Non recommandée systématiquement
Échange de matériel d'injection (y c. chemsex)	Recommandée	N/A (les personnes qui s'injectent des substances appartiennent par définition au groupe à risque élevé)
Rapport bucco-génital avec/sans éjaculation	Non recommandée systématiquement	Non recommandée systématiquement
Cunnilingus avec sang	À évaluer	Non recommandée systématiquement
Piqûre d'aiguille en dehors du domaine médical**	Non recommandée systématiquement	

*Recommandée en cas de viol

**Le risque de contamination par une canule ou autre aiguille abandonnée en dehors du domaine médical est considéré comme négligeable.

Cas particulier : prise insuffisante de la PrEP VIH et différence entre l'EXPOSITION rectale et l'EXPOSITION vaginale

La PrEP VIH protège dans une large mesure contre une infection par le VIH, et de plus en plus de personnes exposées à un risque accru de contracter le VIH prennent ce traitement dans le monde entier.

Contexte : le ténofovir s'accumule rapidement dans les tissus anogénitaux. Sa durée de demi-vie est toutefois plus longue dans la muqueuse rectale que dans la muqueuse vaginale. Il n'existe pas de données concernant le tissu néo-vaginal. Dans le cadre des traitements de réassignation sexuelle, on prescrit souvent des hormones féminisantes aux femmes transgenres ; ces hormones tendent à faire légèrement diminuer le niveau de ténofovir dans le sang (23). En cas d'exposition au VIH lors de la consommation de substances par voie intraveineuse (échange de matériel d'injection), une bonne observance de la PrEP joue un rôle décisif (13). Chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des femmes transgenres (exposition rectale au VIH) sous PrEP VIH en continu, le risque de contamination par le VIH augmente si la prise de la PrEP se limite à moins de quatre doses par semaine (24). S'agissant de la PrEP VIH sur demande (les comprimés ne sont pas pris quotidiennement, mais suivant un schéma de dosage spécial ciblant la période qui précède et qui suit les rapports sexuels), il n'existe pas de données concernant l'observance minimale requise (25).

La liste ci-après résume les situations dans lesquelles il convient d'effectuer une PEP VIH si l'indication correspond aux données du tableau 2 :

PrEP VIH en continu

1. Rapports anaux ou rapports vaginaux insertifs.
   La PEP est recommandée si moins de quatre comprimés de PrEP VIH ont été pris au cours des sept derniers jours. Dans tous les autres cas, la prescription d'une PEP n'est pas nécessaire, mais la PrEP VIH est à poursuivre. Il est toutefois possible d'envisager la PEP si l'observance de la PrEP ne peut être évaluée avec certitude.
2. Rapports vaginaux réceptifs et rapports sexuels chez les personnes sous traitement hormonal féminisant
   La PEP est recommandée si la dernière prise de comprimés de PrEP VIH remonte à plus de 48 heures ou si la prise de comprimés s'est limitée à moins de six comprimés au cours des sept derniers jours.
3. EXPOSITION liée à la consommation de substances par voie intraveineuse (échange de matériel d'injection)
   La PEP est recommandée si la dernière prise de comprimés de PrEP VIH remonte à plus de 48 heures ou si la prise de comprimés s'est limitée à moins de six comprimés au cours des sept derniers jours.

PrEP VIH sur demande

4. PrEP VIH sur demande (prise ciblée avant et après les rapports sexuels)

   La PEP est recommandée si la prise de la PrEP VIH n'était pas conforme aux recommandations.

Les personnes prescrivant la PrEP VIH doivent informer les personnes sous PrEP VIH à l'avance et leur rappeler régulièrement qu'elles doivent prendre immédiatement deux comprimés de PrEP (emtricitabine 200 mg/ténofovir disoproxil [fumarate] 245 mg) et consulter un médecin sans attendre si elles se sont trouvées dans les situations de risque susmentionnées et que la prise de la PrEP VIH est inadéquate. *Chaque heure compte !* (26).

Hepatite B

Les patients dont l'infection par le VHB est traitée au moyen d'une monothérapie avec nucléosides/analogues de nucléosides ne sont pas protégés contre le VIH et doivent donc faire l'objet d'une PEP VIH complète si celle-ci est indiquée. Le traitement contre le VHB doit ensuite être repris sans délai après la PEP VIH, faute de quoi une interruption pourrait entraîner ce qu'on appelle un *flare* (réactivation) de l'infection par le VHB.

Les personnes dont les analyses de base en laboratoire ont conduit à la détection d'une réinfection par le VHB doivent être orientées vers les services de consultation spécialisés en vue de poursuivre le traitement contre le VHB au terme de la PEP VIH.

Choix des médicaments

La tolérance et la facilité d'administration des médicaments jouent un rôle essentiel dans l'observance et par conséquent le succès de la prévention d'une infection par le VIH. Le choix des médicaments doit faire l'objet d'une décision conjointe fondée sur les préférences du patient et les indications et contre-indications liées à un médicament. La durée recommandée de la PEP VIH est de 30 jours. La PEP VIH peut être interrompue à tout moment pendant le traitement si la PERSONNE SOURCE est testée négative pour le VIH et ne se trouve pas dans la fenêtre sérologique, ou si la PERSONNE SOURCE est séropositive et que son taux d'ARN du VIH se situe sous le seuil de détection (< 50 copies/ml). En principe, il est possible d'utiliser dans le contexte de la PEP toutes les trithérapies recommandées pour le traitement du VIH, à l'exception des préparations contenant de l'abacavir et de la névirapine (27). En cas de résistances du VIH connues chez la PERSONNE SOURCE, il faut adapter le traitement à ces résistances et s'appuyer sur l'avis d'un spécialiste du VIH. Le tableau ci-après résume nos recommandations.

Tableau 3 : médicaments pour la PEP VIH (prescrire des médicaments génériques dans la mesure du possible)

Médicament	Avantages	Inconvénients	Coût
Premier choix			
Dolutégravir 50 mg 1x/j**, emtricitabine 200 mg/ténofovir disoproxil (fumarate)* 245 mg 1x/j	1x/jour, très bien établi	Rare : effets secondaires neurologiques et psychiatriques	++
Autres options			
Raltégravir 400 mg 2x/j**, emtricitabine 200 mg/ténofovir disoproxil (fumarate)* 245 mg 1x/j	Tolérance, moins d'interactions	2x/jour, avec éventuellement une moins bonne observance	++
Bictégravir 50 mg/emtricitabine 200 mg/ténofovir alafénamide (fumarate) 25 mg 1x/j	1 comprimé/jour	Prix	+++
Darunavir 800 mg 1x/j, ritonavir 100 mg 1x/j, emtricitabine 200 mg/ténofovir disoproxil (fumarate)* 245 mg 1x/j	Prix, autre option en cas de contre-indication liée aux inhibiteurs d'intégrase	Plus d'interactions qu'avec les inhibiteurs d'intégrase (y c. avec les substances illicites)	+

* Ténofovir alafénamide (fumarate) 25 mg possible en cas de contre-indication pour le ténofovir disoproxil (fumarate) (p. ex. eGFR < 50 ml/min/1,73 m^2)

** Raltégravir 1200 mg 1x/j possible, éventuellement une meilleure observance

Analyses de laboratoire

Référentiel

Avant le début de la PEP VIH, les analyses de laboratoire suivantes sont réalisées chez la PERSONNE EXPOSÉE sans pour autant retarder le début du traitement :

1. Test rapide de quatrième génération pour le VIH afin d'écarter la possibilité d'une infection par le VIH.
2. Créatinine (y compris eGFR) et alanine aminotransférase (ALT). En cas de valeurs très élevées, des examens supplémentaires ainsi qu'une analyse bénéfice-risque ou une adaptation du dosage de la PEP VIH sont indiqués. Les valeurs légèrement anormales ne constituent pas une contre-indication pour une PEP VIH, mais un suivi est recommandé.
3. Sérologie de l'hépatite B (antigènes HBs, anticorps anti-HBs et anticorps anti-HBc) en vue d'écarter la possibilité d'une infection active par le VHB (risque de réactivation de l'hépatite au terme du traitement au ténofovir) et de documenter une éventuelle protection vaccinale. Si le statut vaccinal est inconnu ou incertain, il convient d'administrer une dose de vaccin contre l'hépatite B. En l'absence de protection vaccinale (anticorps anti-HBs < 10 UI/l), il est indiqué de poursuivre la vaccination selon le schéma défini. Si la PERSONNE SOURCE présente une infection par le VHB à réplication active et que la PERSONNE EXPOSÉE n'est pas vaccinée ou est non répondeuse, il convient alors de procéder comme décrit dans les recommandations en cas d'exposition dans le domaine médical (lien).
4. Sérologie de l'hépatite C (anticorps du VHC). Si le test est réactif, on procède à une PCR VHC afin d'exclure une infection active par le VHC, et la prise en charge est ensuite assurée par un médecin ayant de l'expérience en matière de traitement du VHC. En cas d'infection par le VHC chez la PERSONNE SOURCE, ou si le risque d'exposition au VHC est considéré comme élevé (chemsex, échange de matériel d'injection, pratiques sexuelles impliquant du sang), il convient de procéder à une recherche par PCR de l'ARN du VHC chez la PERSONNE EXPOSÉE après trois à six semaines. Après quatre à six mois, un test de dépistage des anticorps du VHC est réalisé, suivie d'une recherche de l'ARN du VHC (test déclenché automatiquement si le test des anticorps du VHC est positif) afin d'exclure tout faux négatif initial en cas de virémie intermittente du VHC.
5. Un test de grossesse est recommandé pour toutes les personnes en âge de procréer et selon les circonstances, il convient en outre d'envisager une contraception post-coïtale (« pilule du lendemain »). Tous les schémas de PEP VIH recommandés ci-dessus sont autorisés pendant la grossesse.

Examens de suivi

Il est préférable qu'un médecin ayant de l'expérience en matière de traitement du VIH assure le suivi de la PEP VIH de la PERSONNE EXPOSÉE. Nous recommandons un contrôle **deux semaines** après le début de la PEP VIH afin d'évaluer l'observance et les effets secondaires. Les analyses de laboratoire (créatinine, ALT) peuvent être renouvelées si nécessaire. En cas d'exposition sexuelle, on peut procéder à ce stade à des tests PCR pour *chlamydia trachomatis* et *neisseria gonorrhoeae* compte tenu

de la sensibilité maximale à ce moment-là. On peut également proposer un test pour la syphilis à cette occasion, mais le test doit être renouvelé au moment de l'examen final car on se trouve encore dans la période de latence sérologique de la syphilis. S'agissant du dépistage des IST asymptomatiques, il faut noter et informer le patient que suivant le contexte, les coûts de ce dépistage ne seront pas pris en charge par des tiers (assurance obligatoire des soins, canton ou commune).

Un **examen final doit être effectué douze semaines** après la fin de la période d'EXPOSITION au moyen d'un test de quatrième génération. En cas d'exposition sexuelle, le test pour le VIH peut être réalisé en même temps que celui pour la syphilis. En fonction du risque individuel, et s'il n'y a pas déjà eu de dépistage après trois à six semaines par PCR VHC en cas de risque élevé d'exposition, un test de dépistage unique de l'hépatite C devrait être proposé à ce moment-là. En attendant le dernier résultat négatif concernant une infection par le VIH, la PERSONNE EXPOSÉE ne doit pas faire don de son sang, ne doit pas avoir de rapports sexuels non protégés et ne doit pas allaiter. Si aucune PEP n'est administrée bien que celle-ci soit indiquée, l'examen final peut avoir lieu six semaines après l'EXPOSITION, là encore au moyen d'un test VIH de quatrième génération.

Si c'est indiqué, il convient de proposer les vaccinations suivantes, toujours en adéquation avec la version actuelle des Directives et recommandations sur la vaccination et la prophylaxie (28) :

- Hépatite A : vaccination indiquée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et les personnes consommant des substances.
- Papillomavirus humain : vaccination indiquée chez toutes les personnes de moins de 27 ans.
- Hépatite B : vaccination indiquée chez toutes les personnes sans protection vaccinale.
- Suivant le contexte épidémiologique, il faut penser à la PEP pour d'autres maladies sexuellement transmissibles, p. ex. le vaccin contre la variole du singe, en PEP et/ou de manière prophylactique (29).

Les personnes qui se présentent pour une PEP VIH et pour lesquelles il existe un risque potentiellement élevé de contamination future par le VIH ou d'autres infections sexuellement transmissibles doivent être encouragées à effectuer régulièrement des dépistages de maladies sexuellement transmissibles. Dans ce contexte, il faut tenir compte du fait que la prise en charge d'un dépistage des IST chez les personnes asymptomatiques n'est pas obligatoire et que la personne concernée devra éventuellement assumer elle-même les coûts engendrés s'il n'existe pas de programme municipal ou cantonal à cet effet. Il est important que cet élément soit porté à la connaissance des personnes concernées avant de procéder au dépistage.
En outre, il faut envisager le démarrage d'une PrEP VIH avec des prescripteurs expérimentés en la matière. Le cas échéant, les personnes présentant un risque élevé peuvent également participer au programme SwissPrEPared (www.swissprepared.ch).
Tous les services de conseil en matière de stratégies de *safer sex* doivent comprendre des informations sur la possibilité de recourir à une PEP VIH. Une procédure standardisée à l'échelle de la Suisse est recommandée pour que la PEP VIH soit accessible rapidement à toute personne, ainsi que pour

informer et former de manière adéquate aussi bien les prescripteurs que les utilisateurs concernant les possibilités d'accès, l'indication et l'utilisation. L'implication de personnel et de services spécialisés est essentielle pour une prescription rapide, correcte et non stigmatisante de la PEP VIH, de même que pour permettre par la suite aux personnes d'accéder à des stratégies de *safer sex*, y compris à des services de conseil sur la PrEP et à des services de dépistage régulier des IST (30).

Prise en charge des coûts

Le coût d'une PEP VIH non liée à l'exercice d'une profession, si elle est médicalement indiquée, est assumé par l'assurance obligatoire des soins, déduction faite de la franchise et de la quote-part.

Réactions

Les recommandations sont soumises à un processus de révision régulier et les réactions à ces recommandations peuvent être envoyées par e-mail à la Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles : office@eksi.admin.ch.

Annexe

Plan des contrôles cliniques et des examens de laboratoire chez la PERSONNE EXPOSÉE

<table>
<tr><th>Se-
maine</th><th colspan="2">VIH*</th><th colspan="2">VHB*</th><th colspan="2">VHC*</th></tr>
<tr><td>0
Exposi-
tion</td><td colspan="2">Test VIH 4e gén.</td><td colspan="2">Ag HBs
Ac anti-HBc
Ac anti-HBs</td><td colspan="2">Ac anti-VHC</td></tr>
<tr><td></td><td>PEP</td><td>Pas de PEP mais exposition significa-
tive</td><td>PEP
Vaccination
plus immuno-
globulines</td><td>PEP
Vaccination
sans im-
muno-globu-
lines</td><td>Personne source positive ou risque d’exposition élevé***</td><td>Rapport anal HSH</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Con-
trôle
cli-
nique</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">PCR VHC</td><td></td></tr>
<tr><td>4
(1 mois)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td>Test VIH 4e gén.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8
(2 mois)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12
(3 mois)</td><td>Test
VIH
4e gén.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ac anti-
VHC

PCR VHC
(si Ac anti-
VHC pos.)</td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16
(4 mois)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="7">Ac anti-VHC

PCR VHC (si Ac anti-VHC pos.)</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20
(5 mois)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>24
(6 mois)</td><td></td><td></td><td>Ag HBs et Ac anti-HBc</td><td>Ag HBs, Ac anti-HBc et Ac anti-HBs**</td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28
(7 mois)</td><td></td><td></td><td rowspan="5">Ac anti-HBs</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32
(8 mois)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

* En cas d’examen sans suspicion d’exposition ou d’immunité démontrée (VHB), un examen de suivi n’est pas nécessaire.

** Le dosage des Ac anti-HBs doit avoir lieu 1 à 2 mois après l’achèvement du schéma de vaccination contre l’hépatite B ou après la dose de rappel.

*** Risque d’exposition élevé : chemsex, échange de matériel d’injection, pratiques sexuelles impliquant du sang

Références

1. Bundesamt für Gesundheit (BAG). Notfall HIV-Exposition – PEP kann die richtige Antwort sein. BAG-Bulletin 48. 24.11.2014.
2. Office fédéral de la santé publique (OFSP). Infections sexuellement transmissibles et hépatites B/C en Suisse : évaluation épidémiologique pour l'année 2022 2023 [cited 2024 Jan 7]. Available from : https://www.bag.admin.ch/dam/fr/sd-web/s3K8D5mHe3Ik/hiv-sti-epizahlen-2022.pdf
3. Tsai CC, Emau P, Follis KE, Beck TW, Benveniste RE, Bischofberger N, et al. Effectiveness of postinoculation (R)-9-(2-phosphonylmethoxypropyl) adenine treatment for prevention of persistent simian immunodeficiency virus SIVmne infection depends critically on timing of initiation and duration of treatment. J Virol. 1998 May;72(5):4265–73.
4. Otten RA, Smith DK, Adams DR, Pullium JK, Jackson E, Kim CN, et al. Efficacy of postexposure prophylaxis after intravaginal exposure of pig-tailed macaques to a human-derived retrovirus (human immunodeficiency virus type 2). J Virol. 2000 Oct;74(20):9771–5.
5. Le Grand R, Vaslin B, Larghero J, Neidez O, Thiebot H, Sellier P, et al. Post-exposure prophylaxis with highly active antiretroviral therapy could not protect macaques from infection with SIV/HIV chimera. AIDS Lond Engl. 2000 Aug 18;14(12):1864–6.
6. Bourry O, Brochard P, Souquiere S, Makuwa M, Calvo J, Dereudre-Bosquet N, et al. Prevention of vaginal simian immunodeficiency virus transmission in macaques by postexposure prophylaxis with zidovudine, lamivudine and indinavir. AIDS Lond Engl. 2009 Feb 20;23(4):447–54.
7. Whitney JB, Hill AL, Sanisetty S, Penaloza-MacMaster P, Liu J, Shetty M, et al. Rapid seeding of the viral reservoir prior to SIV viraemia in rhesus monkeys. Nature. 2014 Aug 7;512(7512):74–7.
8. Bryant J, Baxter L, Hird S. Non-occupational postexposure prophylaxis for HIV: a systematic review. Health Technol Assess Winch Engl. 2009 Feb;13(14):iii, ix–x, 1–60.
9. Schechter M, do Lago RF, Mendelsohn AB, Moreira RI, Moulton LH, Harrison LH, et al. Behavioral impact, acceptability, and HIV incidence among homosexual men with access to postexposure chemoprophylaxis for HIV. J Acquir Immune Defic Syndr 1999. 2004 Apr 15;35(5):519–25.
10. Donnell D, Baeten JM, Kiarie J, Thomas KK, Stevens W, Cohen CR, et al. Heterosexual HIV-1 transmission after initiation of antiretroviral therapy: a prospective cohort analysis. Lancet Lond Engl. 2010 Jun 12;375(9731):2092–8.
11. Choopanya K, Martin M, Suntharasamai P, Sangkum U, Mock PA, Leethochawalit M, et al. Antiretroviral prophylaxis for HIV infection in injecting drug users in Bangkok, Thailand (the Bangkok Tenofovir Study): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet Lond Engl. 2013 Jun 15;381(9883):2083–90.
12. Cohen Myron S., Chen Ying Q., McCauley Marybeth, Gamble Theresa, Hosseinipour Mina C., Kumarasamy Nagalingeswaran, et al. Prevention of HIV-1 Infection with Early Antiretroviral Therapy. N Engl J Med. 2011;365(6):493–505.
13. Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, Vernazza P, Collins S, Degen O, et al. Risk of HIV

transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study. The Lancet. 2019 Jun 15;393(10189):2428–38.
14. UK Guideline for the use of HIV Post-Exposure Prophylaxis 2021 [Internet]. [cited 2023 Jan 15]. Available from: https://www.bhiva.org/PEP-guidelines
15. Gray RH, Wawer MJ. Probability of heterosexual HIV-1 transmission per coital act in sub-Saharan Africa. J Infect Dis. 2012 Feb 1;205(3):351–2.
16. Leynaert B, Downs AM, de Vincenzi I. Heterosexual transmission of human immunodeficiency virus: variability of infectivity throughout the course of infection. European Study Group on Heterosexual Transmission of HIV. Am J Epidemiol. 1998 Jul 1;148(1):88–96.
17. Rothenberg RB, Scarlett M, del Rio C, Reznik D, O'Daniels C. Oral transmission of HIV. AIDS Lond Engl. 1998 Nov 12;12(16):2095–105.
18. Røttingen JA, Cameron DW, Garnett GP. A systematic review of the epidemiologic interactions between classic sexually transmitted diseases and HIV: how much really is known? Sex Transm Dis. 2001 Oct;28(10):579–97.
19. Wald A, Link K. Risk of human immunodeficiency virus infection in herpes simplex virus type 2- seropositive persons: a meta-analysis. J Infect Dis. 2002 Jan 1;185(1):45–52.
20. Thomson KA, Hughes J, Baeten JM, John-Stewart G, Celum C, Cohen CR, et al. Increased Risk of HIV Acquisition Among Women Throughout Pregnancy and During the Postpartum Period: A Prospective Per-Coital-Act Analysis Among Women With HIV-Infected Partners. J Infect Dis. 2018 Jun 5;218(1):16–25.
21. Sadiq ST, Taylor S, Kaye S, Bennett J, Johnstone R, Byrne P, et al. The effects of antiretroviral therapy on HIV-1 RNA loads in seminal plasma in HIV-positive patients with and without urethritis. AIDS Lond Engl. 2002 Jan 25;16(2):219–25.
22. Gitau RW, Graham SM, Masese LN, Overbaugh J, Chohan V, Peshu N, et al. Effect of acquisition and treatment of cervical infections on HIV-1 shedding in women on antiretroviral therapy. AIDS Lond Engl. 2010 Nov 13;24(17):2733–7.
23. Hiransuthikul A, Janamnuaysook R, Himmad K, Kerr SJ, Thammajaruk N, Pankam T, et al. Drug- drug interactions between feminizing hormone therapy and pre-exposure prophylaxis among transgender women: the iFACT study. J Int AIDS Soc. 2019 Jul;22(7):e25338.
24. Grant RM, Anderson PL, McMahan V, Liu A, Amico KR, Mehrotra M, et al. Uptake of pre-exposure prophylaxis, sexual practices, and HIV incidence in men and transgender women who have sex with men: a cohort study. Lancet Infect Dis. 2014 Sep;14(9):820–9.
25. Molina JM, Capitant C, Spire B, Pialoux G, Cotte L, Charreau I, et al. On-Demand Preexposure Prophylaxis in Men at High Risk for HIV-1 Infection. N Engl J Med. 2015 Dec 3;373(23):2237–46.
26. McCormack S. PrEP vs PEP Interface: Where are We Now? The Lock Lecture. HIV Glasgow; 2022.
27. Initial Regimens: ART-naïve Adults [Internet]. EACS Guidelines. [cited 2023 Jan 31]. Available from: https://eacs.sanfordguide.com/art/initial-regimens-arv-naive-adults

28. Bundesamt für Gesundheit (BAG). Schweizerischer Impfplan 2024 [cited 2024 May 7]. Available from: https://www.bag.admin.ch/dam/fr/sd-web/ROsLcMRqhgZR/refdoc-impfplan-2024.pdf
29. Office fédéral de la santé publique (OFSP). Variole du singe : cadre analytique et recommandations de vaccination. Vaccin MVA-BN® (Modified Vaccinia Ankara de Bavarian Nordic). 2022 [cited 2024 May 7]. Available from : https://www.bag.admin.ch/dam/fr/sd-web/NBDOQmBLvNYq/Analyserahmen%20und%20Empfehlungen%20zur%20impfung%20gegen%20Mpox.pdf
30. Benjamin Hampel, Cate Esson, Bernard Surial, Lukas Baumann, Jan Fehr. Recommendations Regarding PrEP Use – The “SwissPrEPared Guidance” Version 3.0. [Internet]. 2023 [cited 2023 Jan 14]. Available from: https://www.swissprepared.ch/de/medical-guidance/